

1 Hemtjänstens verksamhetsbeskrivning

1.1 Bakgrund

Vård- och omsorgsverksamheten genomgår sedan en tid tillbaka en tämligen snabb omstrukturering i två avseenden. För det första pågår en decentralisering av äldreboendet genom att antalet platser på kommunernas särskilda boenden avvecklas till förmån för vård och omsorg i hemmet. För det andra pågår en utveckling där vi får fler och fler äldre vilket gör att omsorgsbehovet ständigt ökar.

Detta innebär att det ställs allt högre krav på planering av hemtjänstens logistik och då spelar IT-systemen en allt viktigare roll.

1.2 Hemtjänstens logistik

Nedan beskrivs hemtjänstens verksamhet och dess logistik.

Klienternas behov och förmåga

Klienten inom hemtjänsten kallas för brukare och är en person som har någon form av funktionshinder. Det kan vara en nedsättning av en fysisk, perceptionell eller en mental förmåga. Detta betyder att brukaren behöver ha hjälp med att tillfredsställa grundläggande behov som mat, dryck, trygghet, hygien och sömn. Detta räknas som omsorgsbehov.

Produkter

Verksamhetens produkter är personlig omvårdnad och består av olika typer värdeskapande handlingar såsom tillsyn, kvällshjälp, morgonhjälp, måltidshjälp, medicinering.

Produkten Akutlarm

En viss typ av insats kallas för akutlarm. Ett akutlarm innebär att en brukare eller annan person trycker på larmknappen i brukarens hem. Detta görs vid en viss tidpunkt som kallas för larmtid. Via en unik larmkod som är kopplad till brukaren vet personalen hos vilken brukare som larmet har gått.

Larmutryckning i samband med akutlarm

En larmutryckning innebär att en i hemtjänstpersonalen åker hem till den brukare som utlöst akutlarmet. Personen registrerar ankomsttid, sluttid och orsak till akutlarmet. Brukaren får sedan en faktura som innehåller den tid som personalen lagt ner på larmutryckningen. Detta syns på den ordinarie fakturan för övriga insatser.

Handlingsöverenskommelse

Handlingsöverenskommelsen beskriver vilka handlingar som skall utföras samt vilken tid detta får ta. Detta definieras i en omsorgsplan som är ett slags ramavtal. Utgångspunkten för omsorgsplanen är ett biståndsbeslut som fattas av en tjänsteman kallad biståndshandläggare. Omsorgsplanen finjusteras sedan av personalen på hemtjänsten med utgångspunkt från de erfarenheter som man får av att bistå den specifika brukaren. Omsorgsplanen skrivs under av brukaren och en från personalen. Innehållet i den man kommer överens om kallas för insats och beskriver de värdeskapande handlingar som ska utföras hos brukaren samt vilken tid dessa får ta.

Denna överenskommelse tolkas och förhandlas om på olika sätt i samband med att verksamheten utförs i samband med att en specifik verksamhetstransaktion (insats) utförs. I planeringsfasen av de specifika insatserna så kan avsteg göras med utgångspunkt från omsorgsplanen beroende på vilken kapacitet som finns tillgänglig. Brukaren kan också be att personalen skall utföra insatserna på ett speciellt sätt när de träffas.

Typhandlingar

Följande typhandlingar utförs i verksamheten.

Värdeskapande handlingar

De värdeskapande handlingar som utförs beskrivs ovan under rubriken produkt.

Handlingar som syftar till att skapa handlingsöverenskommelser

Detta innebär att justera den omsorgsplan som arbetet i hemtjänsten bygger på se ovan.

Planeringshandlingar

Planeringen inom hemtjänsten är mycket viktig. Arbetet måste planeras med utgångspunkt från:

- utlovade insatser
- tillgängliga handlingsresurser
- handlingsrestriktioner
- tid och plats

Rapportering

Rapportering av utförda insatser är en viktig del av arbetet. Det är viktigt att personalen signerar genomförda insatser och att den insattid som brukarna får dokumenteras.

Resultat

Resultatet från hemtjänsten innebär att insatserna utförts enligt planering. Det är också viktigt det sker en rapportering av genomförda insatser. Det är viktigt att genomföra en riktig rapportering av med avseende på vad som genomförts samt med avseende på tid.

Kompensation

Brukarna betalar för den insattid som personalen utför. Vad som skall betalas är inkomstprövat och det finns en maxtaxa som inte får överskridas. Detta regleras av Socialtjänstlagen se nedan.

Lagar och normer

Hemtjänsteverksamheten lyder under Socialtjänstlagen som reglerar kommunernas omsorg i hemmet och hur denna verksamhet skall organiseras samt hur personalen ska utföra sitt arbete. Socialtjänstlagen reglerar hur mycket kommunen får ta betalt av brukarna. När omsorgspersonalen utför sjukvårdsuppgifter t.ex. medicinering räknas de som sjukvårdspersonal som gäller under Hälso- och Sjukvårdslagen vilken styr vilka uppgifter som får delegeras till personalen. Personalen får inte utföra andra sjukvårdande uppgifter än de

som är delegerade. Personalen har också tystnadsplikt. Verksamheten råder också under arbetslagstiftning som både gäller arbetstid och arbetsmiljö.

Producenter

Det är personalen som utför insatserna och personalen består av undersköterskor och omsorgsbiträden. Personalen ansvarar för att utföra omsorgen i brukarnas hem och en kontaktperson finns utsedd för varje brukare.

Handlingsrestriktioner

Verksamheten styrs av olika så kallade restriktioner:

- Det är kontaktpersonen som skall utföra insatsen.
- Det är en person av ett visst kön som skall genomföra insatsen.
- Insatsen skall genomföras som ett dubbelgående.
- Personalen har bara rätt att utföra vissa arbetsuppgifter.

Tid och plats

När det gäller resultatet av planeringen så är det viktigt att skilja på beviljad tid och planerad tid. Ibland så kan man inte alltid planera ut den beviljade tiden genom de handlingsrestriktioner som föreligger eller att man inte har tillgång till tillräckligt med handlingskapacitet.

1.2 Hemtjänsten processer

Ett ärende inom hemtjänsten startas genom att en ansökan om omsorg kommer in. Denna ansökan behandlas av en biståndshandläggare som fattar ett beslut om insatser. Behandlingen av ärendet innebär att biståndshandläggaren genomför ett hembesök. De beslutade insatserna och informationen om brukaren kommuniceras sedan till hemtjänstgruppen.

För att kunna genomföra insatserna behöver dessa planeras. Följande input behövs till planeringen:

- De insatser som skall utföras
- Arbetsschema för den personal som arbetar
- Handlingsrestriktioner

Resultatet av planeringen utgörs av en individuell arbetsorder med planerade insatser för varje person i personalen.

Insatserna utförs sedan med utgångspunkt från arbetsordern, i samband med detta rapporteras en start- och sluttid för varje insats som utförs hos brukaren. Detta sker med hjälp av IT-utrustning i brukarens hem. Personalen attesterar de utförda insatserna när de kommer tillbaka till hemtjänstlokalen.

Med utgångspunkt från de attesterade insatserna kan man sedan skapa ett debiteringsunderlag som skickas till kommunens ekonomisystem som sedan debiterar brukarna för de utförda insatserna.

2 Scenario

2.1 Problem

I Borlänge kommun finns idag ett system som används av biståndshandläggarna för att fatta beslut om insatser från brukarna. Problemet är dock att man behöver ett system för planering och rapportering av genomförda insatser. Problemet med planeringen är att den tar för lång tid och att kvaliteten på planeringen behöver förbättras. Planeringen håller inte tillräckligt hög kvalitet genom att man inte kan ta hänsyn till alla restriktioner och önskemål som bör styra planeringen.

Idag finns ett flertal brister när det gäller rapporteringen av insatserna vilket utgör ett problem för personalen genom att de inte kan redovisa allt som de gör. Detta gör också att man ibland gör felaktiga neddragningar och prioriteringar p.g.a. att beslut fattas på felaktiga grunder. Problemet med den bristfälliga rapporteringen gör också att den tid som olika brukare är berättigade till inte alltid stämmer.

För att lösa dessa problem har kommunen beslutat sig för att investera i IT-systemet iCare som skall klara av planeringen av hemtjänstens insatser samt återrapportering av dessa. Detta IT-system skall integreras med biståndshandläggarnas IT-system (handläggningssystemet).

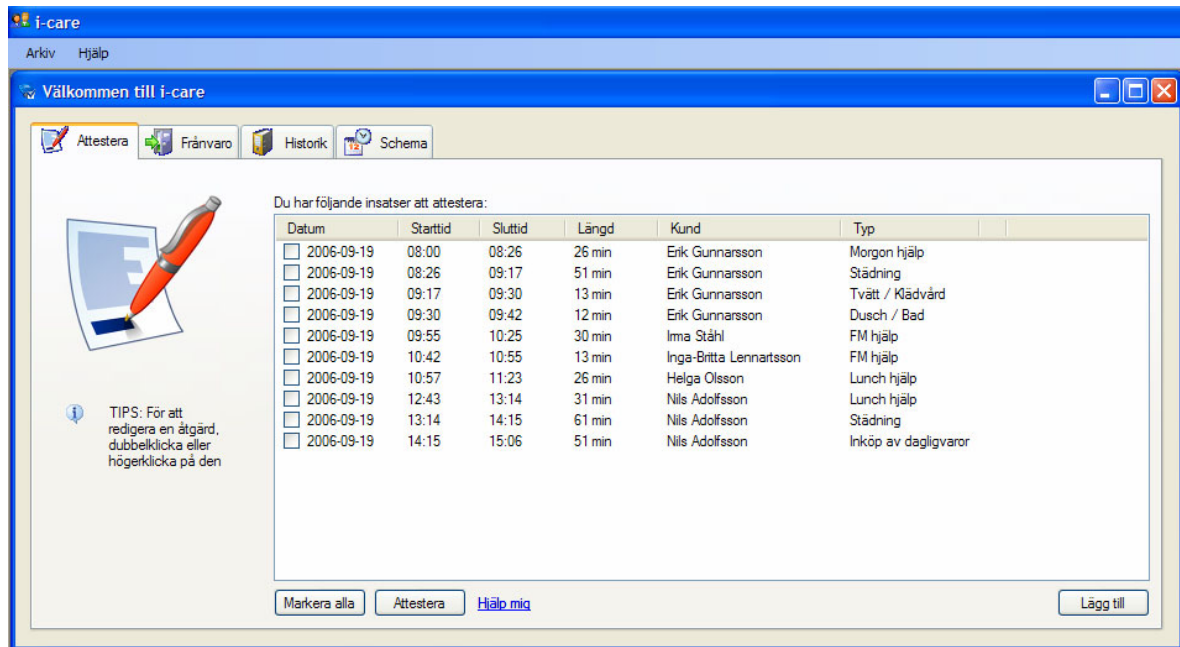
2.2 Handläggningssystemet

Handläggningssystem används av biståndshandläggarna i samband med handläggningen av biståndsbesluten och output från handläggningen är biståndsbeslut. Den information som måste kunna kommuniceras mellan handläggningssystemet och insatssystemet iCare är omsorgsplanen som innehåller information om de beslutade insatserna samt information om brukaren. Exempel på den information som skall kommuniceras från handläggningssystemet framgår av den omsorgsplan som beskrivs enligt bilaga 1.

2.3 i-care

iCare används för planeringen och personalen får en utskriven arbetsorder enligt bilaga 2 som resultat av planeringen. I samband med att insatserna på arbetsordern utförs, rapporterar personalen den tid som de utför hos varje brukare genom att trycka på gul serviceknapp som finns på brukarens larmtelefon. Registreringsenheten aktiveras därmed och blir redo att ta emot information från en knapp som personalen har på sig. I samband med detta sänds informationen till den centrala databasen om vem eller vilka som är på plats. När insatsen är klar trycker personalen på den gröna knappen på brukarens larmtelefon.

När personalen har gjort klart och rapporterat sina insatser attesteras dessa i hemtjänstelokalen med hjälp av följande skärmdokument.



Insatssystemet måste kunna kommunicera med kommunens ekonomisystem så att brukarna kan debiteras och för att sköta ekonomiuppföljningen.

3 Uppgiften

Under denna övningsuppgift ska ni göra en systemarkitekturgraf, informationsmodell och en begreppslista. Alltså det som står under rubrikerna 3.2.1 och 3.2.2.

Om ni tycker att det här är kul och ni känner att ni har tid så kan ni även försöka att hinna med 3.1 Upprätta processbeskrivningar.

Uppgiften som skall lösas är att skapa en systemarkitektur (informationssystemarkitektur) som består att ovanstående system och samverkan mellan dessa system gör att praktiken (verksamheten) fungerar på ett smidigt sätt.

3.1 Upprätta processbeskrivningar

Upprätta processbeskrivningar med utgångspunkt från:

1. Ansökan om bistånd
2. Hembesök (personal i hemtjänsten besöker brukare och utför planeade insatser)
3. Attestering av insatser
4. Ett akutlarm går hos en brukare
5. Fakturering

Här avses detaljerade processer på operativ aktivitetsnivå.

3.2 Utforma systemarkitektur

3.2.1 Systemarkitekturgraf

Skapa en systemarkitekturgraf där man kan se vilka olika informationssystem som finns och hur dessa kommunicerar med varandra (kommunikationsgränssnitt och informationsmängder och format på dessa t.ex. JSON eller XML).

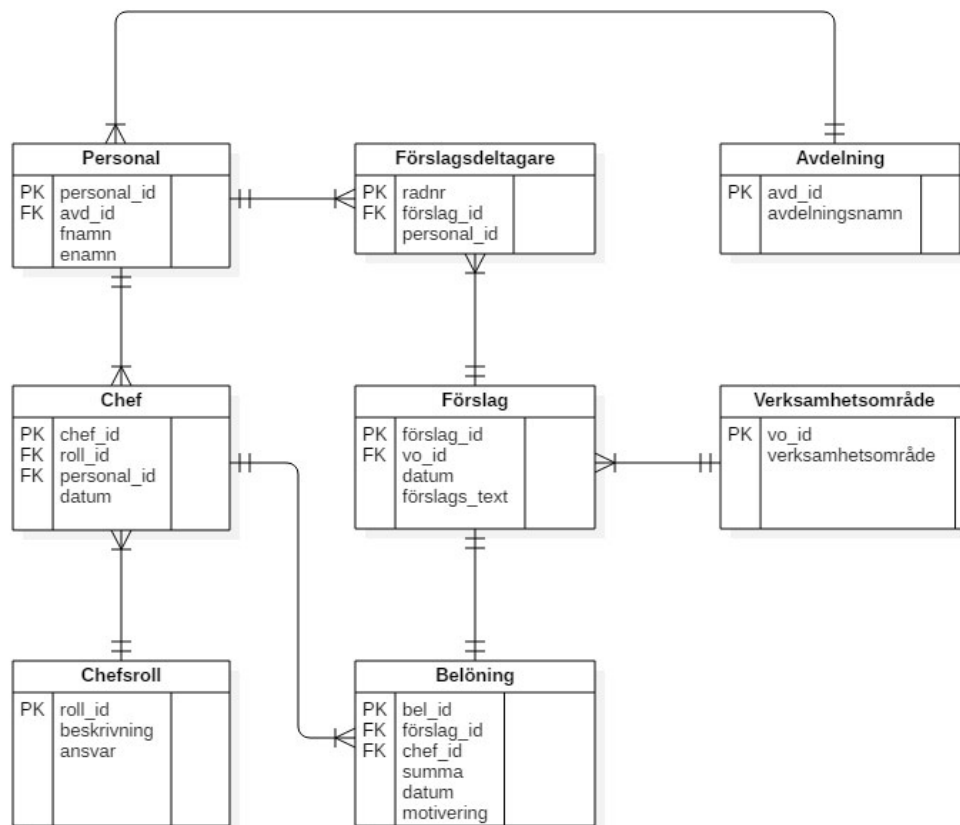
3.2.2 Informationsmodell och begreppslista

Skapa en informationsmodell som bygger på de begrepp och relationer som beskrivs i Hemtjänstens verksamhetsbeskrivning och det som dokumenterats i bilagorna för iCare:

- 01-iCare.pdf
- 02-Omsorgsplan.pdf
- 03-Arbetsorder.pdf

Baserat på informationsmodellen skapa en begreppslista där ni definierar de tabeller(begrepp) som informationsmodellen innehåller. Man ska enkelt kunna först vad en viss tabell fyller för funktion genom att titta i er begreppsmodell för att få en tydlig definition av tabellen.

Så här ska informationsmodellen se ut



Använd Star UML för att rita ER-Diagram. Precis som du gjorde i åk 1 på databaskursen. Om du har glömt hur du använde programmet, så kan du titta på följande korta tutorial:

https://www.youtube.com/watch?v=4LjlaT4_WrM

Med vänlig hälsning

Pär Douhan pdo@du.se